

הרעלת אופיאטים



אופיאטים

- אופיאטים הם קבוצת תרופות וסמים סינתטיים או טבעיים אשר מופגים מצמח האופיום (פרג)

- יצואנית ויצרנית האופיום העיקרית בעולם – איראן



- החומר האופיאטי הידוע ביותר הינו המורפיום

- סם הרחוב האופיאטי הנפוץ ביותר הינו ההרואין

- אופיאטים משפיעים על הרצפטורים האנדוגניים בגוף לאופיאטים

השפעת האופיאטים על הגוף

- דיכוי מרכז הכאבים
- דיכוי מרכז הנשימה
- דיכוי השיעול, ברונכוספאזם, ברדיפניאה
- ערות
- תחושת אופוריה
- בחילה והקאות
- האישונים- מיוזיס (אישוני סיכה)
- כיווץ הספינקטר של מערכת השתן



Nausea and
vomiting



Constipation



Itching



Sleepiness



Slowed
breathing



Impaired motor
skills, thinking,
or judgment

תופעות לוואי



- ברדיקרדיה
- ירידת לחץ דם
- שחרור היסטמין
- גירוד
- ברונקוספאזם
- היפותרמיה
- ירידה במשקל ובתיאבון
- חוסר הכרה
- דיכוי נשימתי
- Acute Withdrawal Syndrome - "קריז"
- סימני גמילה המתאפיינים בסימנים הפוכים מהרשום מעלה, עוררות יתר, עצבנות וגרד

משככי כאבים

- משככי כאבים משמשים כסמי רחוב נפוצים בקרב משתמשי ההרואין
- משמשים על מנת לשבור קריז בזמן מחסור בהרואין
- תרופות מסוג זה ניתן למצוא גם אצל חולי סרטן או סובלים מכאבים כרוניים

- דוגמאות: Oxycontin, Percocet, Percodan
- מדבקות פנטניל ומורפיום



הטיפול באמצעות נרקן



• ABC - חמצן ואמבו טרם טיפול ALS

• אנטידוט - Naloxone/Narcan

• אנטגוניסט אופיואיד

• אינדיקציה: דיכוי נשימתי

• המטרה: שיפור אוורור וחמצון

• אמפולה: 0.4mg/1cc

• IV – אמפולה עם מהילה ל-10cc ומתן בפוש איטי

• IN - מנות חוזרות של 0.4 עד השגת אפקט רצוי

• תופעות לוואי: ייתכנו פרכוסים, השתנה, סימני גמילה (עצבנות, חיוורון והזעה, בחילות..)

טיפול - דגשים

- תשומת לב לבטיחות
- חפשו מדבקות וסימני הזרקה
- יש להנשים את המטופל ולדאוג לחמצון ואוורור נאותים טרם תחילת טיפול תרופתית
- האינדיקציה הטיפולית היא לא חוסר הכרה
- לא כל האופיאטים גורמים להיצרות אישונים
- היצרות אישונים לא נגרמת רק מהרעלת אופיאטים
- תשומת לב להיפותרמיה והפרעות קצב נלווים
- קיימים בצה"ל ובמד"א מזרקים אוטומטיים של 10mg במקרה של מתקפת טרור כימית המערבת סמים אופיאטים (חיזבאללה)

פרוטוקול הרעלת אופיאטים

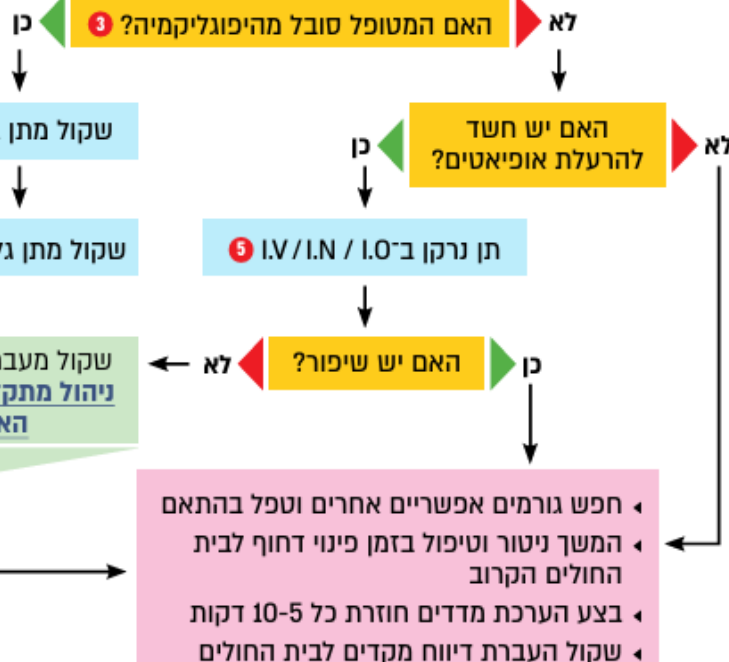
מעודכן לאפריל 2024



שינויים במצב ההכרה של המטופל

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

- אבטח את נתיב האוויר של המטופל
- השכב את המטופל על צידו ככל האפשר
- שקול מתן חמצן
- התקן עירוי תוך-ורידי או תוך-לשדי
- בצע תשאול ובדיקה גופנית מהירה
- בדוק את רמת הסוכר בדם



1 השכבת המטופל על צידו, לשם מניעת אספירציה. השכבת נשים בהריון על צד שמאל.

2 **חמצן**
מתן חמצן כדי לשמור על ערכי סטורציה מעל 92%.

3 **היפוגליקמיה**
+ כאשר ערך סוכר בדם נמוך מ-60 mg% עם תסמינים אופייניים.
+ יש לבדוק האם המטופל מחובר למשאבת אינסולין. אם כן, יש לנתק את צינורית המשאבה.
+ מתן גלוקוג'ל P.O (15 gr) למטופל בהכרה ומשתף פעולה. למטופל בהכרה מעורפלת ניתן לתת במריחה בחלק הפנימי של הלחיים (intrabuccal).

4 **מתן גלוקוז ב-I.V**
+ מינון – 25 gr.
+ תמיסת גלוקוז בריכוז 25%.
+ יש לשוב ולבדוק את ערכי הסוכר בדם.
+ אם אחרי 5 דקות ערכי הסוכר בדם של המטופל עדיין נמוכים – יש לתת מנת גלוקוז נוספת (מחצית המינון).

5 **נרקן**
+ מטרת הטיפול היא שיפור האוורור הריאתי (כלומר, שיפור קצב הנשימות ועומקן) ולא בהכרח לגרום להתעוררות המטופל.
+ מינון למתן ב-I.N – 2 mg (במנות חוזרות של 0.4 mg, עד להשגת אפקט רצוי). אפשר לחזור על המנה לאחר 5-10 דקות.
+ מינון למתן ב-I.V – 0.4-2 mg (מהול ב-10 ml סליין בהזרקה איטית). אם לא חל שיפור ולא הושג האפקט הרצוי, אפשר לתת מנות חוזרות כל 3-5 דקות.
+ מינון מקסימלי מצטבר 10 mg.

היכוננות היכוננות

+ תסמינים סובייקטיביים

- תופעות נוירוגניות – רעד, פלפיטציות, נימול, הזעה, תחושת רעב, חרדה.
- תופעות נוירוגליקופניות – שינויים במצב ההכרה, שינויים במצב הקוגניטיבי של המטופל, פרכוסים.

+ סימנים אובייקטיביים

- חיורון, הזעה, טכיקרדיה, עלייה בלחץ הדם, חסר נוירולוגי.

הרעלת אופיאטים

+ סימנים

- ירידה במצב ההכרה, דיכוי נשימתי (ירידה בקצב הנשימות וב־Tidal volume), ירידה בפריסטלטיקה, היצרות האישון (מיוזיס). כמו כן ייתכנו סימני הזרקה במקומות שונים בגוף.

+ דגשים לבדיקה הגופנית

- בחולים אונקולוגיים יש לחפש נוכחות מדבקות לשחרור מושהה של תרופות.
- בדיקת אישונים תקינה אינה שוללת הרעלת אופיאטים.
- יש לשלול היפותרמיה – זהו מנגנון משולב של הרעלת אופיאטים ושל האפקט הסביבתי.
- יש לחפש סימנים חיצוניים לטראומה.

גורמים נוספים

- חבלת ראש – תשאול ו/או סימנים קליניים לחבלת ראש.
- מחלת חום זיהומית.
- גורמים סביבתיים – הרעלות (בנזודיאזפינים, זרחנים אורגנים) היפותרמיה/היפותרמיה, פגיעות בעלי חיים.
- הפרעות מטבוליות/אלקטרוליטריות (היפונתרמיה, היפרקלצמיה).
- נוירולוגי – אירוע מוחי, לאחר פרכוס, גידול וכדומה.